



Paciente: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

Edad: _____ años Diagnóstico: _____

ECOG: ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Tipo de trasplante: ☐ Autólogo ☐ Otro

Marcar	Comorbilidad	Criterio práctico	Puntos
☐	 Arritmia	Arritmia clínicamente significativa	1
☐	 Cardíaca	Coronariopatía, insuficiencia cardíaca o FEVI $\leq 50\%$	1
☐	 Enfermedad inflamatoria intestinal	Crohn o colitis ulcerosa	1
☐	 Diabetes	Requiere tratamiento farmacológico	1
☐	 Cerebrovascular	ACV o AIT previo	1
☐	 Psiquiátrica	Trastorno que requiere tratamiento	1
☐	 Hepática leve	Hepatitis crónica o alteración leve de bilirrubina/transaminasas	1
☐	 Obesidad	IMC $>35 \text{ kg/m}^2$	1
☐	 Infección	Infección activa que requiere tratamiento	1
☐	 Reumatológica	Enfermedad reumatológica significativa	2
☐	 Úlcera péptica	Antecedente clínicamente relevante	2
☐	 Renal	Creatinina $>2 \text{ mg/dL}$, diálisis o trasplante renal previo	2
☐	 Pulmonar moderada	DLCO o FEVI 66–80% del predicho, o disnea con actividad habitual	2
☐	 Tumor sólido previo	Antecedente de neoplasia sólida previa	3
☐	 Valvulopatía	Enfermedad valvular moderada/grave	3
☐	 Pulmonar grave	DLCO o FEVI $\leq 65\%$ del predicho, o disnea en reposo / requiere O_2	3
☐	 Hepática moderada/grave	Cirrosis, bilirrubina $>1,5 \times \text{LSN}$ o AST/ALT $>2,5 \times \text{LSN}$	3

PUNTAJE TOTAL HCT-CI: _____ **puntos**

Orientación: 0 = baja carga de comorbilidad | 1–2 = intermedia | ≥ 3 = alta

Datos útiles: FEVI _____ % | FEV1 _____ % | DLCO _____ % | Cr _____ mg/dL | IMC _____ kg/m²

Conducta práctica según Sociedad Argentina de Hematología (SAH)

En quimioterapia intensiva / LMA

- En adultos mayores, la SAH recomienda valorar la aptitud para quimioterapia intensiva integrando:
 - Estado funcional (ECOG/PS).
 - Comorbilidades (puede utilizarse HCT-CI o Charlson).
 - Evaluación geriátrica integral.
- El HCT-CI **no debe utilizarse** como criterio aislado para decidir la indicación de quimioterapia intensiva.

En candidatos a trasplante

- La SAH recomienda considerar el HCT-CI junto con el estado funcional para estimar la mortalidad relacionada al tratamiento y apoyar la decisión de trasplante.
- Un HCT-CI >2 se asocia a mayor mortalidad no relacionada con recaída.
- La edad cronológica por sí sola no debe definir la indicación de trasplante.
- En pacientes con comorbilidades puede considerarse un acondicionamiento de intensidad reducida, según evaluación integral del riesgo.



Nota: El HCT-CI orienta riesgo; no constituye una contraindicación absoluta por sí solo.



Referencias bibliográficas:

- Sorror ML, Maris MB, Storb R, et al. Hematopoietic cell transplantation (HCT)-specific comorbidity index: a new tool for risk assessment before allogeneic HCT. Blood. 2005;106(8):2912–2919. doi:10.1182/blood-2005-05-2004.
- Sorror ML. How I assess comorbidities before hematopoietic cell transplantation. Blood. 2013;121(15):2854–2863. doi:10.1182/blood-2012-09-455063.
- Sociedad Argentina de Hematología. Guías de Diagnóstico y Tratamiento 2023: Leucemia Mieloide Aguda y Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas.



Consultorio GHEMAS
Arrieta 1728,
Villa Luzuriaga



Consultorio Baruch
Agüero 1235,
Morón



Turnos / WhatsApp:
11 5403 0229